



Receita Federal

Coordenação-Geral de Tributação

Cosit

Fis. 1

Solução de Consulta Interna nº 11 - Cosit

Data 28 de junho de 2012

Origem DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 6ª REGIÃO FISCAL.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF

Ementa: A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas específicas de cada ente.

O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o nº de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o nº de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.

Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público, independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.

Dispositivos Legais: Art. 6º, incisos XIV e XXI, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988; art. 30, **caput**, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995.

(Protocolo Gedoc nº 13.103/2010)

R

al

R

n

Relatório

A Divisão de Tributação da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 6ª Região Fiscal (Disit/SRRF06) encaminhou a esta Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) a Consulta Interna SRRF06/Disit nº 1, de 22 de setembro de 2010, mediante a qual foi apresentado questionamento acerca da interpretação do termo "laudo pericial" constante do art. 30 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Questionou-se, também, se os serviços médicos, vinculados às Secretarias Municipais de Saúde, que exercem atendimento na forma de consultas médicas e emergências, tais como Hospitais-escola, Postos de Saúde, e Unidades de Pronto Atendimento, têm competência para emitir laudos periciais para fins de isenção do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF).

2. Esta Cosit já se manifestou acerca deste assunto nas Soluções de Consulta Interna (SCI) Cosit nº 28, de 8 de novembro de 2005, e 5, de 30 de abril de 2007, conforme se verifica nas emendas abaixo:

SCI Cosit nº 28, de 2005:

EMENTA: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física. Reconhecimento de isenção por moléstia grave. Aplicabilidade do termo "conclusão da medicina especializada".

Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e alterações posteriores, sem prejuízo das demais exigências legais relativas à matéria, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cujo(s) médico(s) responsável(is) pela emissão do laudo não necessita(m) ser especializado(s) na área da medicina correspondente à moléstia motivante da isenção.

SCI Cosit nº 5, de 2007:

EMENTA: Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e alterações posteriores, sem prejuízo das demais exigências legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições públicas, independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Os laudos periciais expedidos por entidades privadas, não atendem à exigência legal e, portanto, não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS;

A legislação exige que o laudo pericial seja emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não havendo qualquer referência à obrigatoriedade de vinculação entre a fonte pagadora dos rendimentos e a instituição pública emitente do laudo pericial;

Não há necessidade de o laudo pericial ser elaborado por uma 'junta médica', podendo ser elaborado por um único médico, desde que vinculado a serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

A moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cujo(s) médico(s) responsável(is) pela emissão do laudo não necessita(m) ser

especializado(s) na área da medicina correspondente à moléstia motivante da isenção.

3. A Disit/SRRF06 elaborou a SCI SRRF06/Disit nº 1, de 8 abril de 2010, conceituando o termo "laudo pericial", pois, segundo a mesma, tal definição não foi contemplada na SCI Cosit nº 5, de 2007:

EMENTA: A isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria recebidos por portadores de moléstia grave depende de comprovação por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial.

Laudo pericial é o documento que formaliza uma perícia médica realizada por profissional médico investido na função de perito por ato administrativo, ou na falta de perito, por junta médica com atribuição pericial.

Serviços médicos, vinculados às Secretarias Municipais de Saúde, que exercem atendimento na forma de consultas médicas e emergências, tais como Universidades, Postos de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento, têm competência para emitir laudos periciais para fins de isenção do Imposto de Renda, desde que possuam médico ou junta médica com atribuições periciais. Neste caso, o exame médico pericial deve ser pautado pelos ditames éticos da profissão, levando-se em conta que a relação perito/periciando não se estabelece nos mesmos termos da relação médico/paciente.

Fundamentos

4. Faz-se necessário para análise do objetivo deste caso (laudo pericial), transcrever o art. 30 da Lei nº 9.250, de 1995, e os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988, verificando a alteração do termo "medicina especializada" para "laudo pericial":

Lei nº 7.713, de 1988:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

(...)

XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,

el

11

3

exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.

(Grifou-se).

Lei nº 9.250, de 1995:

Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

(Grifou-se).

5. Cabe, também, reproduzir os conceitos de “laudo pericial” e “perito” das páginas 477 e 604 do livro Vocabulário Jurídico, de De Plácido e Silva, 19ª edição:

LAUDO PERICIAL. É a designação dada à peça escrita pelo perito, na qual faz relatório de sua perícia ou exame, respondendo aos quesitos formulados e dando as suas conclusões ou parecer.

Laudo pericial, assim, é designação genérica, pois compreende qualquer espécie de laudo, isto é, atende àquele que é dado para qualquer espécie de perícia.

PERITO. Do latim *peritus*, exprime, na linguagem técnica do Direito, a pessoa que, nomeada pelo juiz, ou escolhida pelas partes, em uma demanda ou litígio, vai participar ou realizar uma *perícia*.

Quando se trata de examinar questão de *ordem técnica e profissional*, o perito deve ser o técnico ou hábil na respectiva profissão.

O perito habilitado, ou técnico, tanto pode ser aquele que se mostra habilitado legalmente para o exercício de certa profissão, como aquele que exerce efetivamente um ofício mecânico, sendo, por isso, senhor de sua arte e ofício.

Nesta razão, no conceito jurídico, *perito* entende-se o homem hábil (experto), que, por suas qualidades ou conhecimentos, está em condições de esclarecer a situação do fato ou do assunto, que se pretende aclarar ou pôr em evidência, para uma solução justa e verdadeira da contenda.

(Grifou-se).

6. Nesse sentido, verifica-se que o Conselho Federal de Medicina (CFM) e o Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) emitiram pareceres dispondo que o médico legalmente habilitado pode realizar perícias, independente de especialidade:

PARECER CFM nº 17/2004, aprovado em sessão plenária de 14/05/2004

(...)

CONCLUSÃO

Os Conselhos regionais de Medicina não exigem que um médico seja especialista para trabalhar em qualquer ramo da Medicina, podendo exercê-la em sua

4

plenitude nas mais diversas áreas, desde que se responsabilize por seus atos e segundo a Resolução CFM nº 1.701/03, não as propague ou anuncie sem realmente estar neles registrado como especialista.

(...)

PARECER CFM nº 33/98, aprovado em reunião de diretoria em 23/04/1998

(...)

X – Especialidade Médica

Vale ressaltar que a exigência da especialidade médica confronta com a norma constitucional, legal e ética.

A Carta magna de 1988 dispõe em seu inciso XIII, art. 5º que é “livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as qualificações profissionais que a lei estabelece.”

(...)

Por outro lado, o Decreto nº 20.931/32 e a Lei nº 3.268/57, que norteiam a profissão de médico, em nenhum momento, referem-se à especialidade médica como captação ou qualificação para o exercício da medicina.

O título de especialista não é requisito para exercer qualquer área reconhecida como especialidade médica, mas sim para anunciá-la. (art. 20 da Lei nº 3.268/57)

(...)

Conclui-se, desta forma, que nenhuma lei ou norma confere privilégios ao médico portador de título de especialista, sendo preceito maior o livre exercício do médico em todas as áreas da medicina, sem restrições e discriminações.

(...)

Em respondendo os quesito **ab initio** perfilados, temos que:

(...)

4) Basta o título de especialista da área fim para atuar como perito?

Em princípio, não há exigência de especialidade para que o profissional atue como perito.

(...)

PARECER CRM-PR nº 2.027/2008, aprovado em reunião plenária nº 2.132, de 15/12/2008

(...)

Salienta ainda que embora a especialidade na Medicina pretenda determinar um maior conhecimento na área designada, isto não impede que o médico que não detenha a especialidade não possua os mesmos conhecimentos técnicos.

Do exposto podemos responder ao consulente que o médico está legalmente habilitado a realizar perícias e auditorias independentemente de ser especialista na área considerada para a perícia.

(...) Grifou-se.

§

gr e

✓

7. Assim, depreende-se que o laudo pericial, disposto no art. 30 da Lei nº 9.250, de 1995, é um parecer técnico emitido por médico legalmente habilitado, vinculado a serviço médico oficial, não havendo a necessidade de especialização na área considerada para a perícia, mas que possua conhecimentos na identificação da moléstia grave prevista no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988, ou seja que o profissional tenha condições de esclarecer a existência ou não da moléstia grave.

8. Entretanto, verifica-se que alguns entes federativos estabelecem a obrigatoriedade da designação formal do médico como perito para exercer as atividades de perícias no serviço médico oficial, devendo ser respeitadas, tendo em vista que cada ente federativo tem autonomia para estabelecer sua legislação e as normas internas.

8.1. Por exemplo, a União instituiu, por meio da Portaria da Secretaria de Recursos Humanos (SRH) nº 797, de 22 de março de 2010, o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, adotando como referência nos procedimentos periciais em saúde na Administração Pública Federal para os servidores civis federais, o qual estabelece que os peritos oficiais em saúde e a composição da junta oficial em saúde tem que ser, obrigatoriamente, designados em documento legal. Acrescente-se, também, que o Decreto nº 7.003, de 9 de novembro de 2009, no seu art. 2º, considera como perícia oficial a avaliação técnica presencial, realizada por médico ou cirurgião-dentista formalmente designado, destinada a fundamentar as decisões da administração.

8.2. No que se refere ao servidor militar da União, a Portaria Normativa do Ministério da Defesa nº 1.174, de 6 de setembro de 2006, dispõe que as Juntas de Inspeção de Saúde da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e do Hospital das Forças Armadas realizarão as perícias para avaliação da incapacidade decorrente de doenças, dentre elas as previstas no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988.

9. Assim, deve-se respeitar a independência dos entes federativos quanto a obrigatoriedade da designação formal de perito, salientando-se que, onde não houver legislação ou norma interna acerca desta designação, poderá o médico vinculado ao serviço médico oficial exercer as atividades de perito para emitir laudo pericial, disposto no art. 30 da Lei nº 9.250, de 1995, concedendo as isenção do IRPF estabelecida nos incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988.

10. No que tange a eficácia do laudo pericial, este documento deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - o órgão emissor;

II - a qualificação do portador da moléstia;

III - o diagnóstico da moléstia, compreendendo:

a) a descrição;

b) o código correspondendo à Classificação Estatística Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde – Décima Revisão (CID-10);

c) os elementos que o fundamentaram;

d) a data em que a pessoa física é considerada portadora de moléstia grave, nos casos constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo;

IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial, ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e

V - o nome completo, a assinatura, o nº de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o nº de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.

11. Registre-se que, a alteração para o termo "laudo pericial" a que se refere o **caput** do art. 30 da Lei nº 9.250, de 1995, foi justificada no voto do relator, Deputado Federal Antônio Kandir, do Projeto de Lei nº 1.236, de 1995, nas páginas 93 e 94 do Diário da Câmara dos Deputados, de 6 de dezembro de 1995:

15) Art. 30 (art. 29 do projeto original) – isenção dos rendimentos de aposentadoria e pensão, em razão de moléstia grave.

Pela legislação em vigor, o reconhecimento da isenção dos rendimentos de aposentadoria e pensão, do contribuinte portador das moléstias graves definidas em lei, é condicionada à comprovação da doença por meio de parecer ou laudo técnico emitido por dois médicos especialistas na área respectiva ou por entidade médica oficial da União, conforme consta do § 3º do art. 40 do regulamento do Imposto de Renda.

Ocorre que, na concessão da aposentadoria em razão das referidas moléstias, para os funcionários públicos federais e para os trabalhadores sujeitos à previdência do INSS (isto é, na absoluta maioria dos casos), o laudo de reconhecimento da doença é fornecido por entidade médica oficial da União. Todavia, quando a isenção é pleiteada após a pessoa já estar aposentada, o laudo pericial pode ser fornecido por dois médicos especialistas na área respectiva, quando, nem sempre, segundo informações da Secretaria da Receita Federal, são observados os mesmos critérios da entidade médica oficial da União.

Assim, para evitar privilégios indevidos que podem ocorrer, o projeto de lei, na versão original, propunha que o laudo pericial fosse emitido, sempre (inclusive quando o pleito da isenção ocorresse após a aposentadoria), por junta médica oficial da União. Trata-se de mudança que tem procedência. Todavia, a exigência, em qualquer caso, de laudo emitido por junta médica oficial da União poderia dificultar a vida de contribuintes que se localizem em áreas geográficas mais pobres e distantes dos centros maiores.

Para evitar transtornos desnecessários, altera-se a redação do dispositivo, exigindo-se laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A redação proposta no Substitutivo objetiva também facilitar a vida de funcionários públicos estaduais e municipais, de Estados e Municípios que mantêm serviço próprio de previdência social.

(...) Grifou-se.

12. Pela análise da exposição de motivos acima, conclui-se que a redação proposta no Substitutivo, aprovada e sancionada no art. 30 da Lei nº 9.250, de 1995, objetivava dar tratamento igual aos ativos e inativos, portador das moléstias graves, em relação ao

cl

7

reconhecimento da isenção dos rendimentos de aposentadoria e pensão, e facilitar a obtenção da isenção pelos contribuintes localizados em áreas geográficas distante dos grandes centros.

12.1. Assim, a pessoa física portadora de moléstia grave, independente de encontrar-se ativo ou inativo, deve apresentar laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dando, assim, o mesmo tratamento em relação ao procedimento adotado para obtenção da isenção.

13. É oportuno ratificar os conceitos de serviço médico oficial, discriminados na SCI SRRF10/Disit nº 134, de 10 de outubro de 2008:

9. Serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é o serviço médico dos órgãos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações públicas.

9.1. No âmbito federal, o Instituto Nacional do Seguro Social preenche os requisitos legais para fornecimento do laudo pericial.

9.2. Nos Estados e Municípios, os serviços de saúde próprios das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, prestados nas Unidades ou Postos de Atendimento, também são considerados serviços médicos oficiais. Ressalte-se que entidades privadas contratadas ou conveniadas, embora prestem serviços de saúde gratuitos, não são oficiais.

9.3. Hospitais universitários e de ensino, que participem do Sistema Único de Saúde mediante convênio, serão considerados oficiais se constituídos sob a forma de autarquia ou fundação pública.

9.4. Os serviços de saúde pertencentes às estruturas das pessoas jurídicas de direito público – independentemente do Poder ao qual se vinculem – e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, são considerados serviços médicos oficiais, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.250, de 1995. Os servidores públicos, civis ou militares, podem recorrer a estes órgãos para obtenção do laudo pericial.

14. Em suma, serviço médico oficial é o serviço de saúde pertencente a estrutura das pessoas jurídicas de direito público, independentemente do Poder ao qual se vinculem, e as autarquias e as fundações, instituídas e mantidas pelo Poder Público.

14.1. Nesse sentido, somente podem ser aceitos, para fins da isenção por moléstia grave, laudos médicos expedidos por instituições criadas e mantidas pelo Poder Público, independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Já os laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal e, portanto, não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.



Conclusão

15. Em face do exposto, pode-se afirmar que:

15.1 A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. O(s) médico(s) responsável(is) pela emissão do laudo não necessita(m) de especialização na área considerada para a perícia, devendo possuir conhecimentos na identificação da moléstia grave prevista no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988, ou seja, que o profissional tenha condições de esclarecer a existência ou não da moléstia grave.

15.2. O médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, pode exercer as atividades periciais, independentemente se investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas específicas de cada ente.

15.3. O laudo deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - o órgão emissor;

II - a qualificação do portador da moléstia;

III - o diagnóstico da moléstia, compreendendo:

a) a descrição;

b) o código correspondendo à Classificação Estatística Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde – Décima Revisão (CID-10);

c) os elementos que o fundamentaram;

d) a data em que a pessoa física é considerada portador da moléstia, nos casos constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo;

IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial, ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e

V - o nome completo, a assinatura, o nº de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o nº de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.

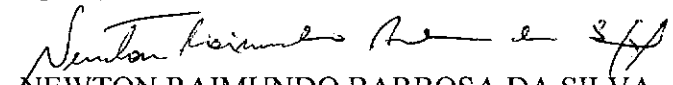
15.4. Serviço médico oficial é aquele que integra órgão público federal, estadual ou municipal (pessoa jurídica de direito público interno, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público). Somente podem ser aceitos para fins da isenção por moléstia grave laudos médicos expedidos por instituições públicas, independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Já os laudos médicos expedidos por entidades privadas, não atendem à exigência legal e, portanto, não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.

[Handwritten signatures and initials]

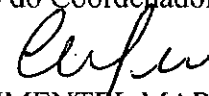
À consideração superior.


MANAILA MACEDO ROMEU
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil (RFB)

De acordo. À consideração da Coordenadora da Coordenação de Tributos sobre a Renda, Patrimônio e Operações Financeiras (Cotir).


NEWTON RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA
Auditor-Fiscal da RFB - Chefe da Divisão de Impostos sobre a Renda de Pessoa Física e a Propriedade Rural (Dirpf)

De acordo. À consideração do Coordenador-Geral de Tributação.


CLÁUDIA LÚCIA PIMENTEL MARTINS DA SILVA
Auditora-Fiscal da RFB - Coordenadora da Cotir

Despacho de Aprovação Cosit nº 13

Data: 28 de junho de 2012

Aprovo a Solução de Consulta Interna.

Encaminhe-se à SRRF06/Disit para ciência e demais providências que se fizerem necessárias. Dê-se ciência, ainda, mediante correio eletrônico, às demais Disit, às Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil (SRRF), às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), à Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial (Cocaj), à Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis) e à Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac), bem como providencie-se a divulgação na Internet da RFB.


FERNANDO MOMBELLI
Auditor-Fiscal da RFB – Coordenador-Geral da Cosit